BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS

La réanimation du nouveau-né à la naissance (NNN)

FMA des chefs d'agrès
2022 - 2023



Généralités

- Lors de la réanimation du NNN, le chef d'agrès et ses équipiers doivent réaliser des gestes techniques **rapidement** et **simultanément**, mais **sans affolement**.
- Qu'est ce qui fait qu'on va travailler **sans affolement** ?

La connaissance ! ✚ **L'entrainement de l'équipe !**





Généralités

- De quoi dépend l'animation du NNN ?

La mise en route de la respiration !

- Lors de la manœuvre, qui est « à la respiration » ?

C'est le chef d'agrès !

- Il se place donc à la tête du NNN et s'efforce de faciliter la mise en route de la respiration.

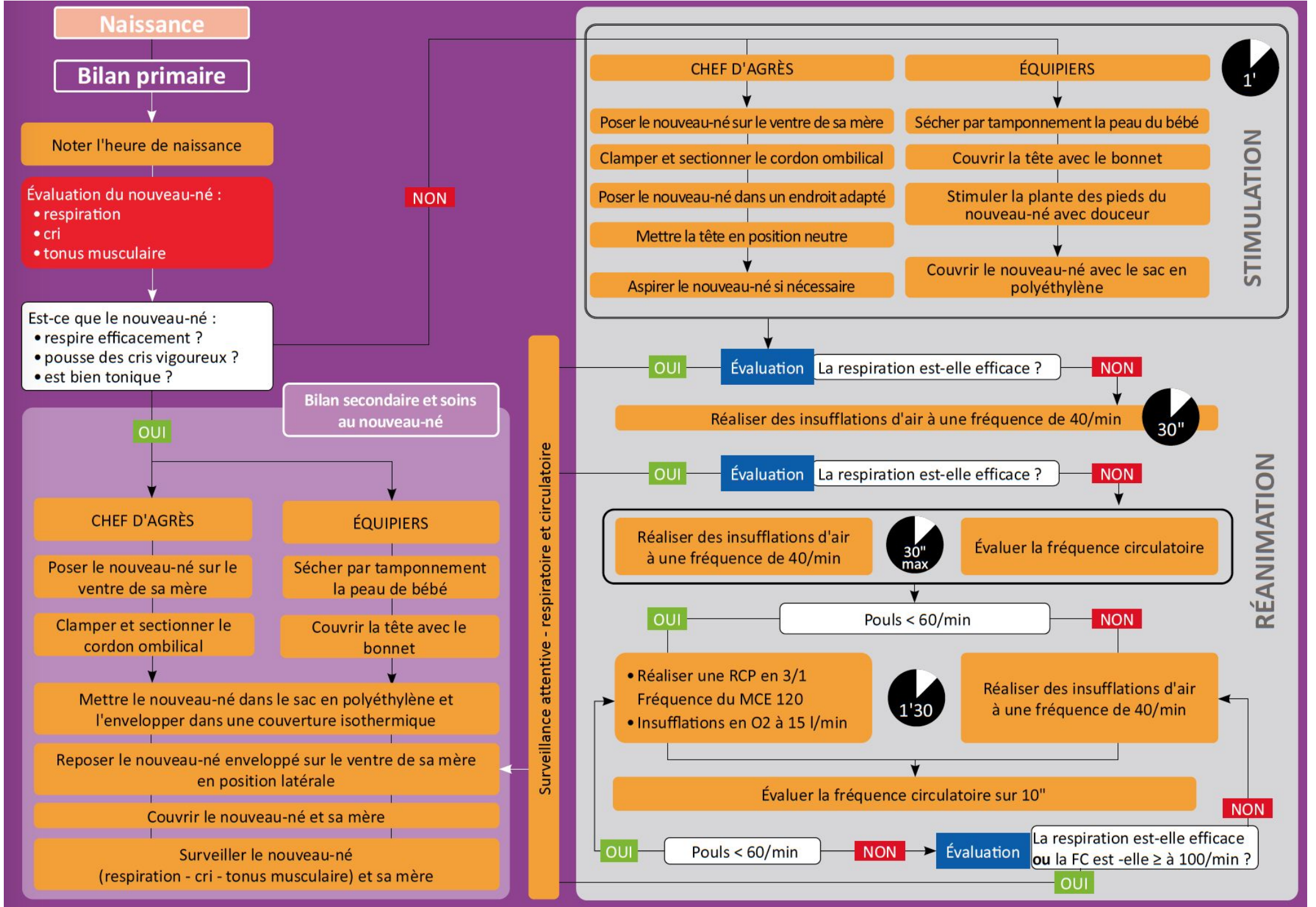
Généralités

- Ces gestes techniques permettent souvent la mise en route de la respiration du NNN, sans aller jusqu'à la réalisation du massage cardiaque.

- La réanimation du NNN à la naissance se décompose en 3 phases. Ces étapes doivent être strictement respectées pour animer le NNN.

- Toutes les ressources de l'équipe doivent être consacrées à l'animation du NNN !

Rien n'est plus important à cet instant que d'animer le NNN !


Naissance
Bilan primaire
Noter l'heure de naissance
Évaluation du nouveau-né :
• respiration
• cri
• tonus musculaire
Est-ce que le nouveau-né :
• respire efficacement ?
• pousse des cris vigoureux ?
• est bien tonique ?
NON
OUI
Bilan secondaire et soins au nouveau-né
CHEF D'AGRÈS
Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère
Clamper et sectionner le cordon ombilical
ÉQUIPIERS
Sécher par tamponnement la peau de bébé
Couvrir la tête avec le bonnet
Mettre le nouveau-né dans le sac en polyéthylène et l'envelopper dans une couverture isothermique
Reposer le nouveau-né enveloppé sur le ventre de sa mère en position latérale
Couvrir le nouveau-né et sa mère
Surveiller le nouveau-né (respiration - cri - tonus musculaire) et sa mère
Surveillance attentive - respiratoire et circulatoire
CHEF D'AGRÈS
Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère
Clamper et sectionner le cordon ombilical
Poser le nouveau-né dans un endroit adapté
Mettre la tête en position neutre
Aspirer le nouveau-né si nécessaire
ÉQUIPIERS
Sécher par tamponnement la peau du bébé
Couvrir la tête avec le bonnet
Stimuler la plante des pieds du nouveau-né avec douceur
Couvrir le nouveau-né avec le sac en polyéthylène
1'
STIMULATION
OUI
Évaluation
La respiration est-elle efficace ?
NON
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
30"
OUI
Évaluation
La respiration est-elle efficace ?
NON
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
30" max
Évaluer la fréquence circulatoire
OUI
Pouls < 60/min
NON
• Réaliser une RCP en 3/1
Fréquence du MCE 120
• Insufflations en O2 à 15 l/min
1'30
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
Évaluer la fréquence circulatoire sur 10"
NON
OUI
Pouls < 60/min
NON
Évaluation
La respiration est-elle efficace ou la FC est -elle ≥ à 100/min ?
OUI
RÉANIMATION

Avant l’accouchement

- Combien de zones y a-t-il lors d’un accouchement et qu’y a-t-il dans chaque zone ?

La parturiente

La zone d’accueil

La zone de réanimation

Que fait le CA dès la sortie du NNN ?

Le bilan primaire du NNN !

Absence de cri ou existence d'un geignement
Tonus faible ou absent
Respiration absente ou inefficace, irrégulière, bruyante, avec tirage, apnée ou gasps

Défavorable !

Il donne des ordres

Équipier manœuvre — Sèche, stimule, protège du froid

Équipier logistique — Active la zone de réanimation

Il change ses gants et coupe le cordon

Phases A, B et C

STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

A = AIRWAY

Libération des VAS

A : AIRWAY

B = BREATHING

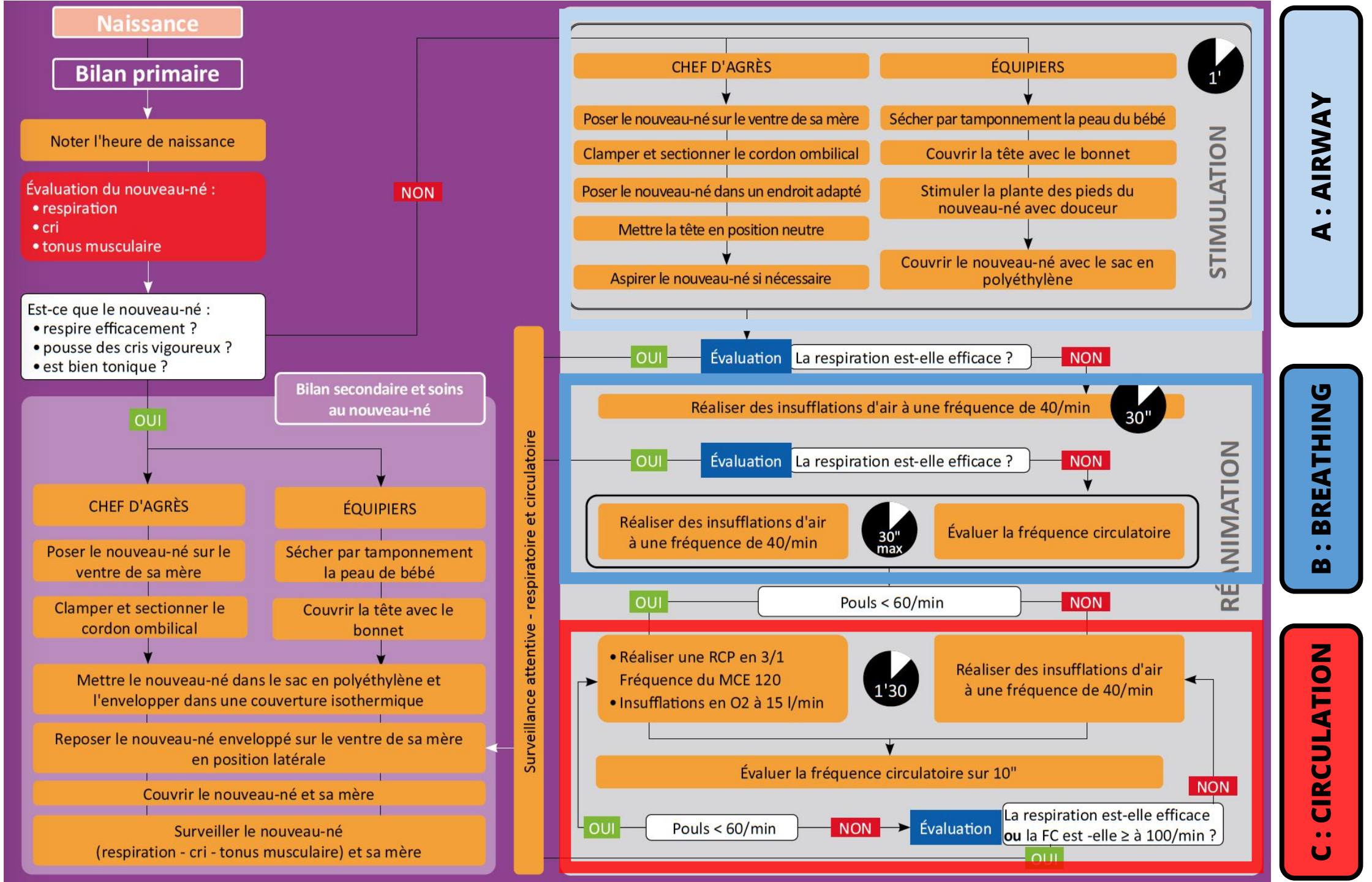
Ventilations en air et mesure de la FC

B : BREATHING

C = CIRCULATION

RCP en 3/1, 120/min, cycles de 1’30”

C : CIRCULATION


Naissance
Bilan primaire
Noter l'heure de naissance
Évaluation du nouveau-né :
• respiration
• cri
• tonus musculaire
Est-ce que le nouveau-né :
• respire efficacement ?
• pousse des cris vigoureux ?
• est bien tonique ?
NON
OUI
Bilan secondaire et soins au nouveau-né
CHEF D'AGRÈS
Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère
Clamper et sectionner le cordon ombilical
ÉQUIPIERS
Sécher par tamponnement la peau de bébé
Couvrir la tête avec le bonnet
Mettre le nouveau-né dans le sac en polyéthylène et l'envelopper dans une couverture isothermique
Reposer le nouveau-né enveloppé sur le ventre de sa mère en position latérale
Couvrir le nouveau-né et sa mère
Surveiller le nouveau-né (respiration - cri - tonus musculaire) et sa mère
Surveillance attentive - respiratoire et circulatoire
CHEF D'AGRÈS
Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère
Clamper et sectionner le cordon ombilical
Poser le nouveau-né dans un endroit adapté
Mettre la tête en position neutre
Aspirer le nouveau-né si nécessaire
ÉQUIPIERS
Sécher par tamponnement la peau du bébé
Couvrir la tête avec le bonnet
Stimuler la plante des pieds du nouveau-né avec douceur
Couvrir le nouveau-né avec le sac en polyéthylène
1'
STIMULATION
OUI
Évaluation
La respiration est-elle efficace ?
NON
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
30"
OUI
Évaluation
La respiration est-elle efficace ?
NON
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
30" max
Évaluer la fréquence circulatoire
RÉANIMATION
OUI
Pouls < 60/min
NON
• Réaliser une RCP en 3/1
Fréquence du MCE 120
• Insufflations en O2 à 15 l/min
1'30
Réaliser des insufflations d'air à une fréquence de 40/min
Évaluer la fréquence circulatoire sur 10"
NON
OUI
Pouls < 60/min
NON
Évaluation
La respiration est-elle efficace ou la FC est -elle ≥ à 100/min ?
OUI
A : AIRWAY
B : BREATHING
C : CIRCULATION

Phase A : AIRWAY

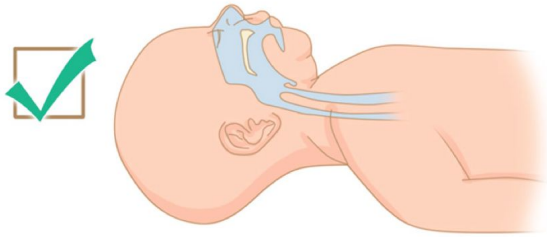
STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

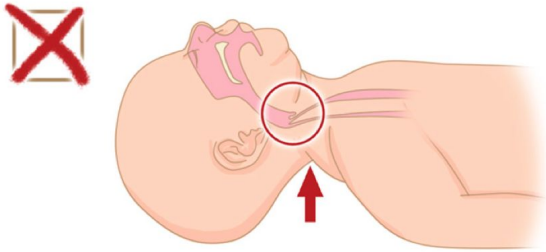
1. LVA par position neutre :
   - Vérifier si la tête du NNN est en position neutre : regard perpendiculaire au plafond
   - Utiliser si nécessaire un pansement américain ou une couverture de survie non dépliée

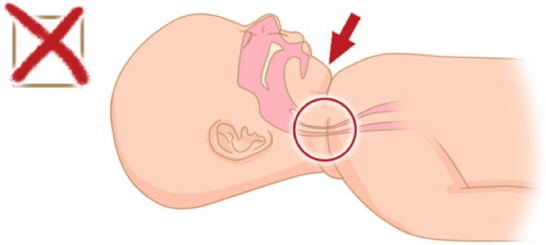




A : AIRWAY







Phase A : AIRWAY

2. LVA par aspirations :
   - Aspirations de la bouche (5 cm), puis des 2 narines (1 cm)
- Refaire un bilan primaire en fin de phase A

A : AIRWAY

STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

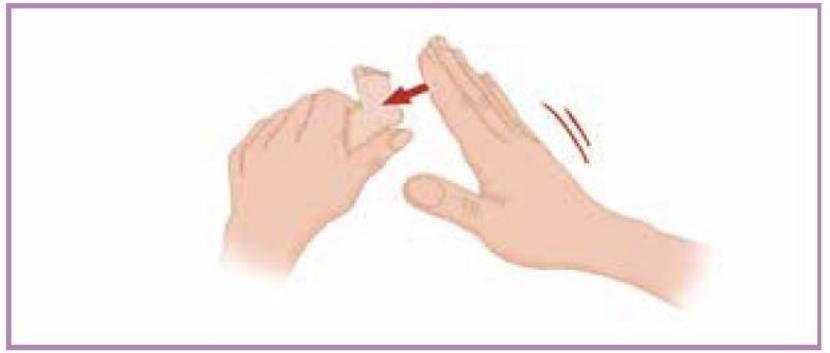


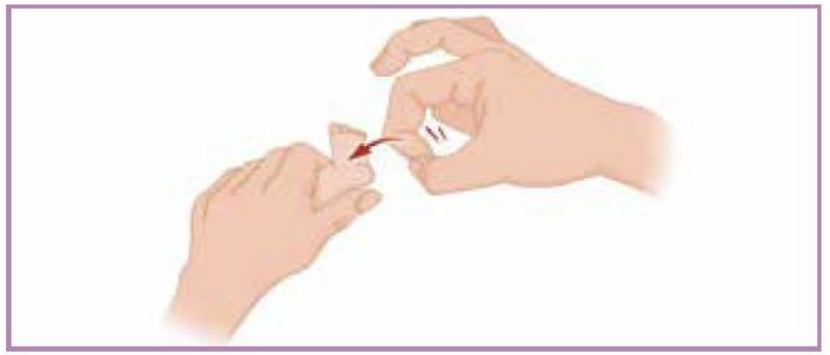




Stimulation et protection thermique

- Rôle de l’équipier manœuvre.
- Débutent dès la sortie de l’enfant, se poursuivent en phases A et B.
- Cela commence par le séchage par tamponnement de l’enfant en l’enveloppant dans une serviette.
- Une fois en zone de réanimation, l’ équipier pose le sac à bébé sur le NNN.
- La stimulation se fait ensuite en grattant et en tapotant la plante des pieds du NNN.





STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

Phase B : BREATHING

B : BREATHING

- Insufflations en air :
  - 1er cycle de 20 insufflations en air sur 30”
  - Bilan primaire
  - 2ème cycle de 20 insufflations en air sur 30” maximum



STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE



Phase B : BREATHING

- Contrôler l'efficacité des insufflations :
  - Tête en position neutre
  - Soulèvement du thorax
  - Voies aériennes libres, sans sécrétions

B : BREATHING



STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

Phase B : BREATHING

STIMULATION et PROTECTION THERMIQUE

- Mesure de la FC simultanée aux insufflations :

  - **Objectif : après le 1er cycle de 20 insufflations, avoir dès que possible une FC.**

  - Mesure électrique de la FC en ne collant que 3 électrodes pédiatriques.
  - La mesure doit apparaître au cours du 2ème cycle d'insufflations…
  - …et le chef d'agrès doit donc la commander dès le début du 1er cycle d'insufflations pour obtenir le résultat au bon moment !
  - Dès que la mesure apparaît lors du 2ème cycle, il faut interrompre le cycle et passer à la suite de







Phase B : BREATHING

- Si la pose du DGT7 est impossible, le CA peut mesurer la FC par une prise de pouls :
  - sur le cordon ombilical
  - en huméral



Analyse de la FC électrique

- **FC < 60/min :**

  MCE en 3/1, 120/min, O_2 15 L/min, cycles de 1’30”

- **FC entre 60 et 100/min :**

  20 insufflations/30” en air, cycles de 1’30”

- **FC > 100/min : apprécier la respiration**
  - Si la respiration est efficace (elle le sera généralement si FC > 100) :

    alors NNN animé !
  - Si respiration inefficace (peu probable) :

    20 insufflations/30” en air, cycles de 1’30”

Phase C : CIRCULATION

Comment réaliser correctement la RCP lors la phase C et notamment le MCE ?



Phase C : CIRCULATION

- RCP en 3/1, compressions d'un tiers du thorax
- 120/min
- avec oxygène 15 L/min
- cycles de 1'30"

C : CIRCULATION



À quel moment demander les renforts ?





Après le 1er cycle de 1’30”



Vidéo d’instruction